

Анализ результатов хирургического лечения колоректального рака в онкохирургическом отделении

Досан Б.О.

Центральная больница г. Жезказган

В структуре злокачественных опухолей по частоте встречаемости колоректальный рак находится на 4-ом месте, уступая раку легких, желудка и молочной железы. На долю злокачественных новообразований ободочной кишки приходится до 20%, в то время, как опухоли прямой кишки занимают 80% в структуре колоректального рака (1).

Частота локализации рака в различных отделах ободочной кишки неодинакова. В силу этиопатогенетических моментов 50% приходится на сигмовидную кишку. Раком толстой кишки заболевают преимущественно люди в возрасте 40-46 лет. Частота рака кишки у мужчин и женщин примерно одинакова.

Радикальным методом лечения рака толстой кишки является хирургический. Пятилетняя выживаемость после оперативного лечения колоректального рака не превышает 50%. Основной причиной высокой смертности от рака толстой кишки является поздняя диагностика, из-за чего 70% больных поступает в стационар с распространенным опухолевым процессом. Вместе с тем, известно, что при ранних стадиях развития опухоли 90-100% оперированных живут от 5 до 15 лет (1).

Цель исследования

– анализ результатов хирургического лечения колоректального рака по данным ЦБ г.Жезказгана.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов хирургического лечения больных раком ободочной и прямой кишки за 1999-2009 г.г., состоящих на диспансерном учете в ЦБ. Всего 93 пациента, мужчин – 51, женщин – 42. Распределение больных по возрасту представлено в таблице № 1.

Со II ст опухолевого процесса было 27 больных, с III стадией – 46 и IV – 20 пациентов. Распределение боль-

Таблица 1 – Распределение больных раком ободочной и прямо кишки

Пол	Всего	По возрасту				
		До 30 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 и более
Мужчины	51	2	9	16	13	11
Женщины	42	1	7	12	14	8
Итого	93	3	16	28	27	19

Таблица 2 – Распределение больных колоректальным раком по возрасту в зависимости от стадии опухолевого процесса

Стадия	Всего больных	По возрасту			
		30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 и более лет
II	27	3	9	7	8
III	46	4	10	15	17
IV	20	2	11	3	4
Итого	93	9	30	25	29

Анализ результатов хирургического лечения колоректального рака в онкохирургическом отделении

Досан Б.О., к.м.н

Проведенный анализ результатов хирургического лечения колоректального рака показал высокий процент послеоперационных осложнений (26%) и летальности (12%), подтвердил прямую зависимость отдаленных результатов от степени распространенности опухолевого процесса. 5 – летняя выживаемость снижается вдвое при III стадии заболевания по сравнению со II стадией.

ных по возрасту в зависимости от стадии представлено в таблице 2.

В таблице 3 перечислены виды оперативных вмешательств, выполненных по поводу колоректального рака.

Полученные результаты и обсуждение

Показатель послеоперационных осложнений при операциях на толстой кишке составил по нашим данным 26%. Основной причиной детальных исходов явился перитонит,

Таблица 3 - Характер выполненных операций при колоректальном раке

№	Вид операции	Кол-во больных
1	Гемиколэктомия справа	9
2	Гемиколэктомия слева	11
3	Резекция поперечно-ободочной кишки	7
4	Резекция сигмовидной кишки	13
5	Операция Гартмана	12
6	Передняя резекция прямой кишки	14
7	Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки	16
8	Паллиативные операции	11
	Всего	93

Таблица 4 - Отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака

Пол	Всего	По возрасту			
		До 3-х лет	3-5 лет	5-10 лет	10 и более лет
Мужчины	51	17	9	14	11
Женщины	42	15	7	12	8
Итого	93	32	16	26	19

Таблица 5 - Отдаленные результаты оперативного лечения рака толстой кишки в зависимости от стадии

Стадии	Всего	Отдаленные результаты			
		До 3-х лет	3-5 лет	5 и более лет	10 и более лет
II	27	-	1	19	7
III	46	12	15	7	12
IV	20	20	-	-	-
Итого	93	32	16	26	19

возникший на почве несостоятельности швов соустья в 15% случаев. Меньший удельный вес занимают осложнения со стороны сердечно – сосудистой системы, легких и другие, на их долю пришлось 11%. Общая послеоперационных летальность после хирургического лечения колоректального рака составила 12%.

Продолжительность жизни является основным критерием эффективности лечения онкологических больных. В таблице 4 даны показатели выживаемости больных колоректальным раком после оперативного лечения.

Более 5 лет из 51 мужчин живут 25 больных, что составляет 49,0 %, а из 42 женщин – 20 больных, что составляет 47,6%.

В таблице №5 представлены отдаленные показатели оперативного лечения рака толстой кишки в зависимости от стадии.

Из больных колоректальным раком, оперированных со II стадией заболевания, более 5 лет живут 26 пациентов, что составило 96,3% от всех больных данной группы. с III стадией заболевания более 5 лет живут 19 больных, на их долю пришлось 41,3% от всех пациентов с III стадией.

Таким образом, проведенный анализ результатов хирургического лечения колоректального рака показал высокий процент послеоперационных осложнений (26%) и летальности (12%), подтвердил прямую зависимость отдаленных результатов от степени распространенности опухолевого процесса. 5 – летняя выживаемость снижается вдвое при III стадии заболевания по сравнению со II стадией.

Список использованной литературы

1. Рак ободочной и прямой кишки / Под ред. В.И. Кныш. – М.: Медицина, 1997-304 с.